

La Vessie : Anatomie, Physiologie et ROP



Le Panorama Clinique

La Femme — Incontinence

40%

des femmes souffrent d'Incontinence Urinaire d'Effort (IUE) au cours de leur vie.

Déclenchée par la toux, l'éternuement, ou le levage. Mécanisme de pression abdominale supérieure à la résistance sphinctérienne.

La Femme — Cystite

1 sur 2

développera une cystite ou cystalgie.

Souvent liée à l'activité génitale, la dysbiose intestinale ou aux troubles statiques du bassin (grossesse, accouchement). Fortement hormono-dépendante.

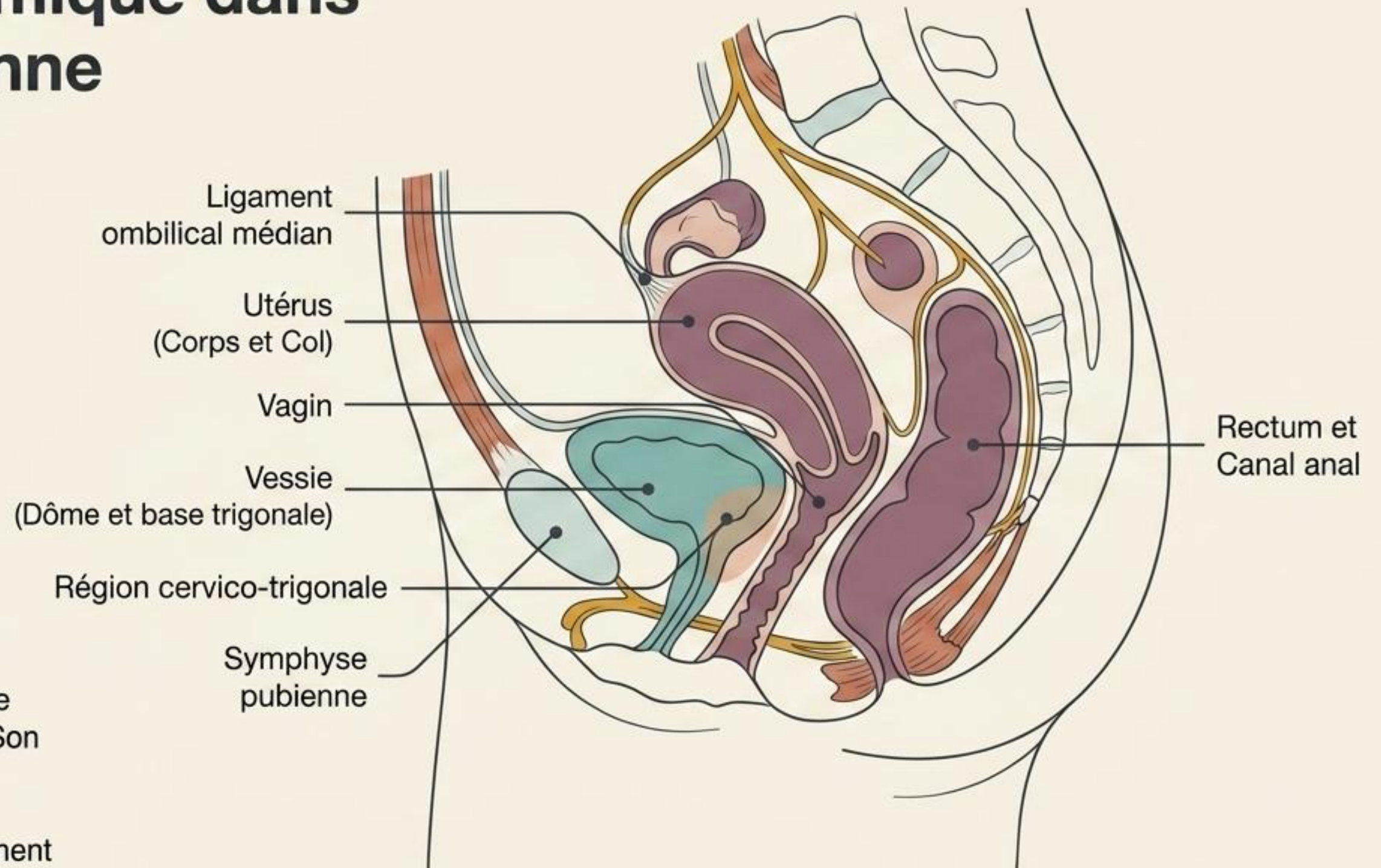
L'Homme — Sénescence

60+

ans : âge d'apparition fréquent des difficultés urinaires.

Majoritairement causées par l'hypertrophie bénigne de la prostate impactant la dynamique urétrale.

Situation Anatomique dans la Cavité Pelvienne (Femme)

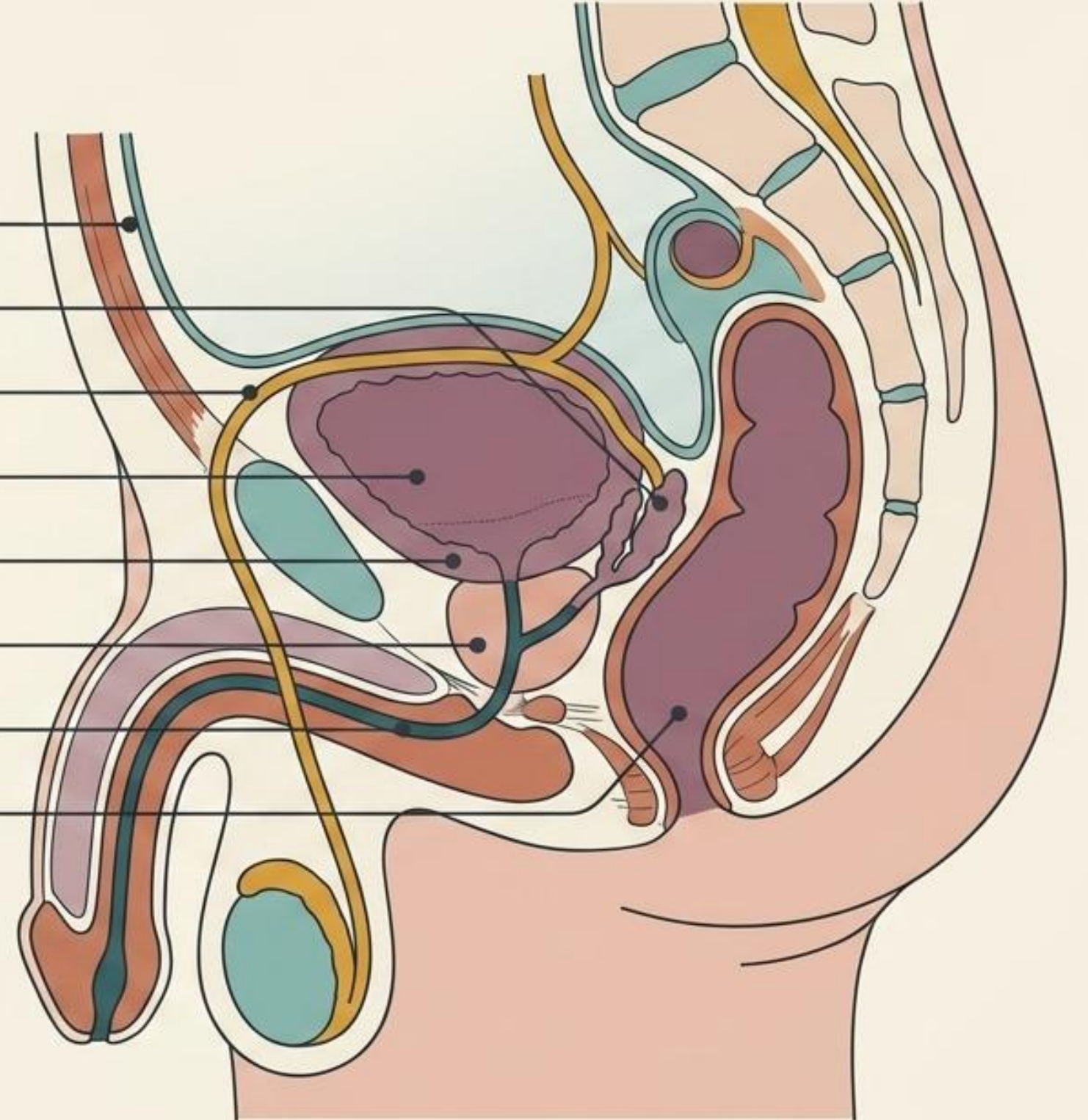


Logée dans la loge viscérale, la vessie féminine repose en arrière du pubis. Son dôme est recouvert par l'utérus et le péritoine, tandis que sa face postéro-inférieure (trigonale) s'appuie directement sur la paroi vaginale, la rendant vulnérable aux ptoses pelviennes.

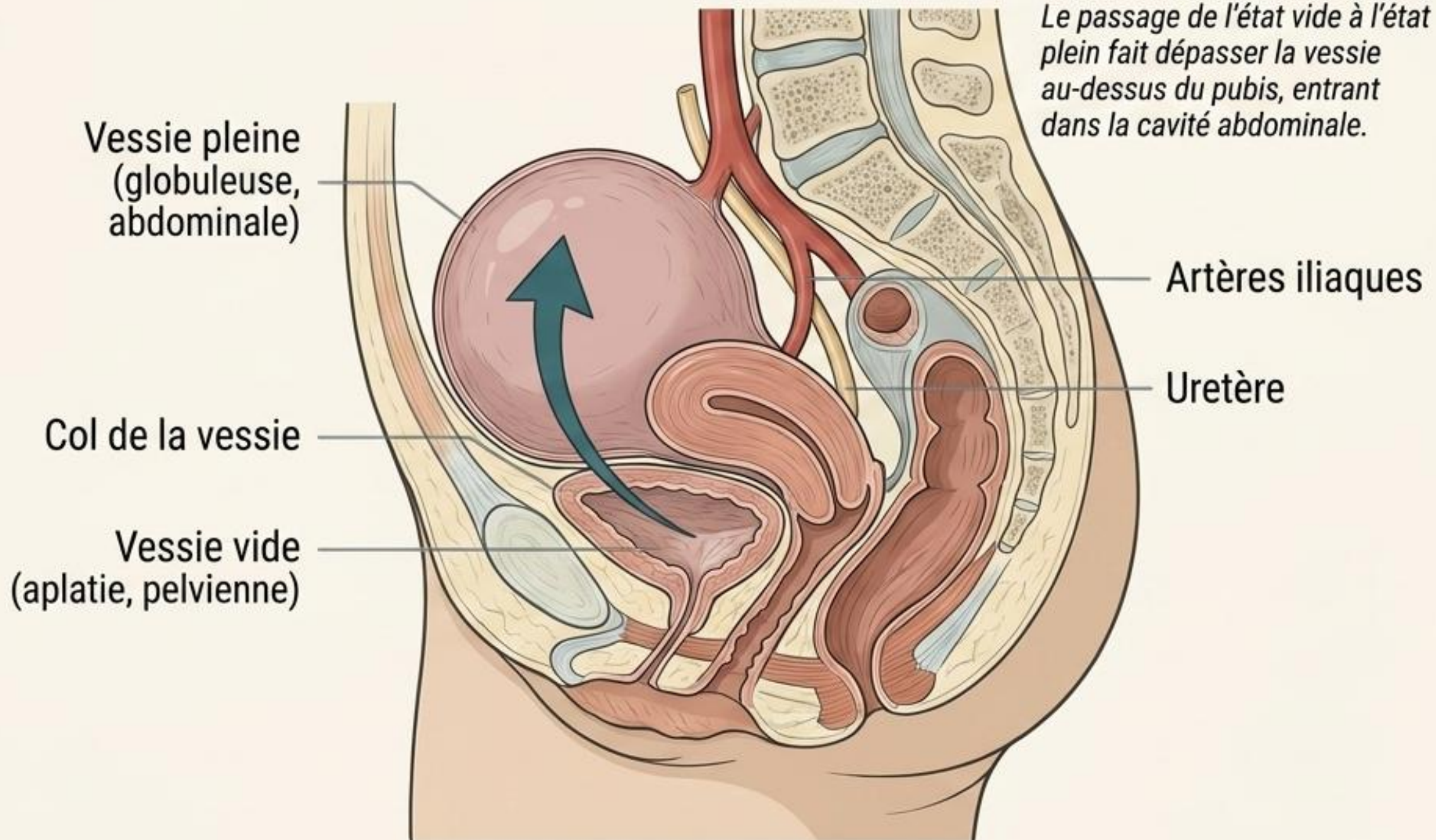
Situation Anatomique dans la Cavité Pelvienne (Homme)

Ligament ombilical médian
Vésicule séminale
Conduit déférent
Vessie
Région trigonale
Prostate
Canal éjaculateur
Rectum

Chez l'homme, la vessie se situe au-dessus de la loge prostatique et en avant du rectum. La partie supérieure (corps) reste mobile sous le péritoine, tandis que la base et le col sont fermement solidaires de l'urètre et de la prostate.



Morphologie et Dynamique Volumétrique

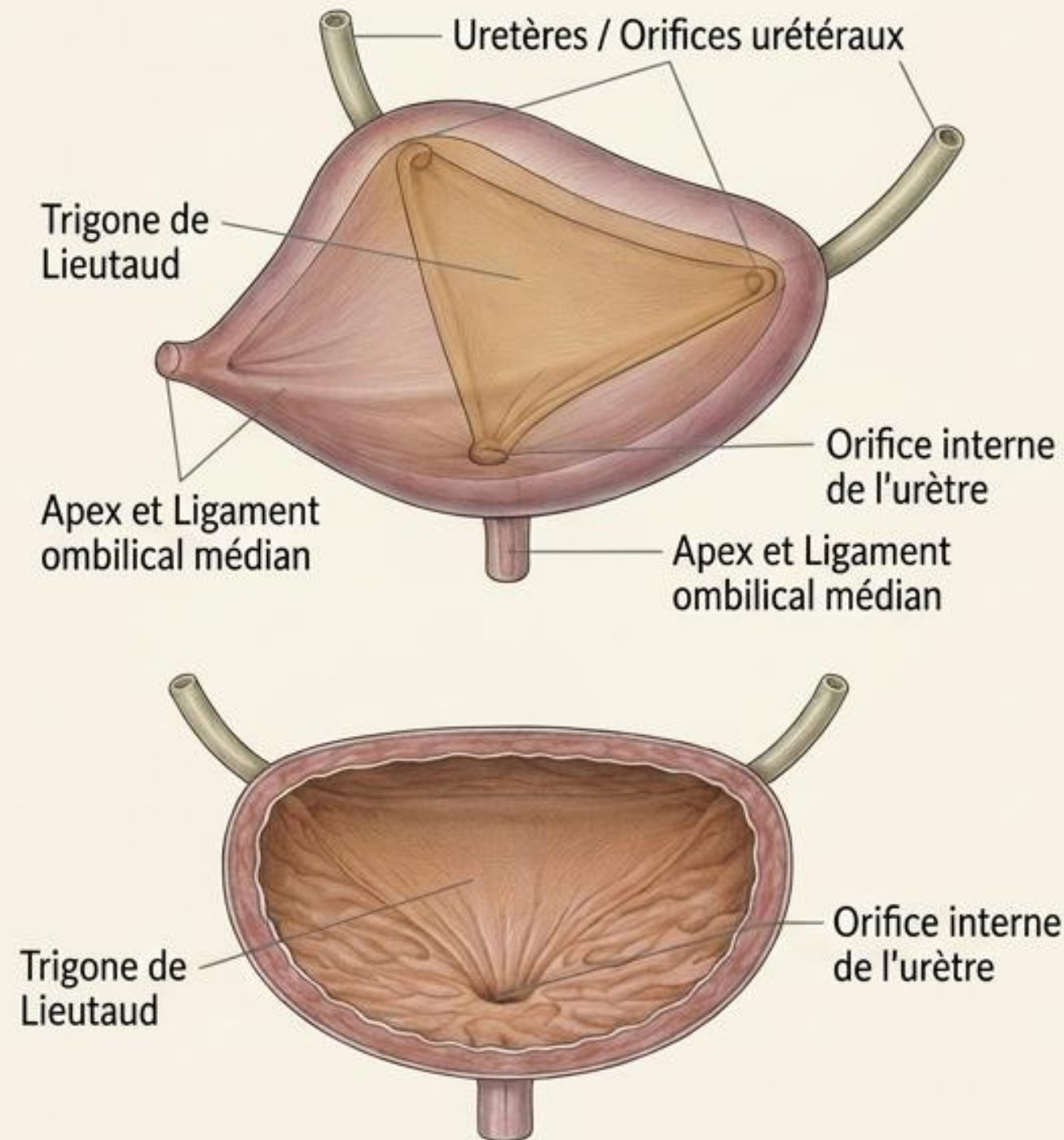


Le Continuum

Il existe un continuum anatomique direct entre la symphyse pubienne, les fascias, et le col de la vessie.

La base et le col restent fixés au plancher pelvien, tandis que le corps (dôme) reste mobile.

Architecture Interne : Le Détrusor et le Trigone



Le Muscle Détrusor

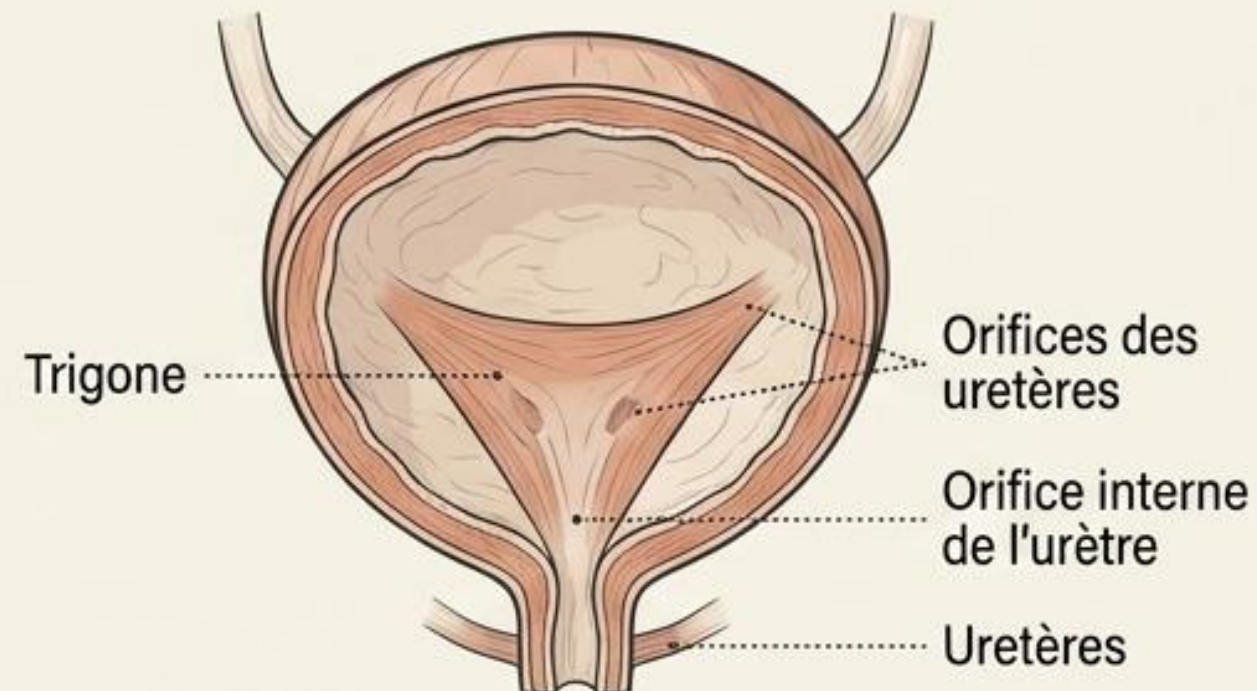
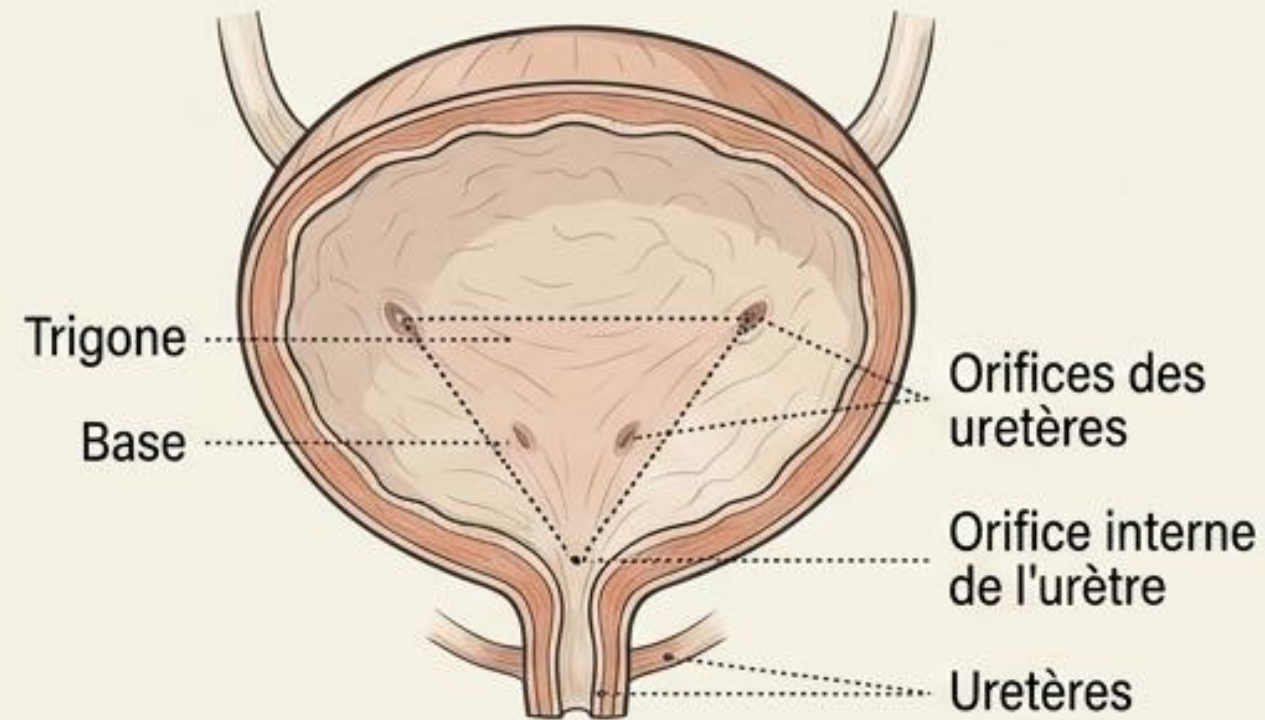
Trois couches de fibres lisses :

1. **Fibres externes (longitudinales)** : S'entremêlent avec les ligaments pubo-vésicaux.
Note : Une tension asymétrique provoque un éréthisme vésical.
2. **Fibres moyennes (circulaires)** : Forment le sphincter lisse interne.
3. **Fibres internes (entrecroisées)** : Se développent fortement (vessie de lutte) face à un obstacle prostatique.

Le Trigone de Lieutaud

Zone triangulaire reliant les uretères et l'urètre. C'est la zone fonctionnelle majeure, riche en tensio- et volo-récepteurs. Lors de la miction, sa contraction donne à la vessie une forme d'entonnoir assurant un écoulement laminaire.

Morphologie Interne : Le Trigone de Lieutaud



Rôle Fonctionnel

Zone hautement stratégique, riche en tensorécepteurs et volorécepteurs.

Dynamique de Miction

→ Contraction des fibres musculaires → La vessie prend une forme d'entonnoir → Écoulement laminaire de l'urine.

Pathologie Biomécanique



Plissement du trigone (stase post-mictionnelle) → perte de la géométrie en entonnoir → douleurs, spasmes (ténésme), et incontinence.

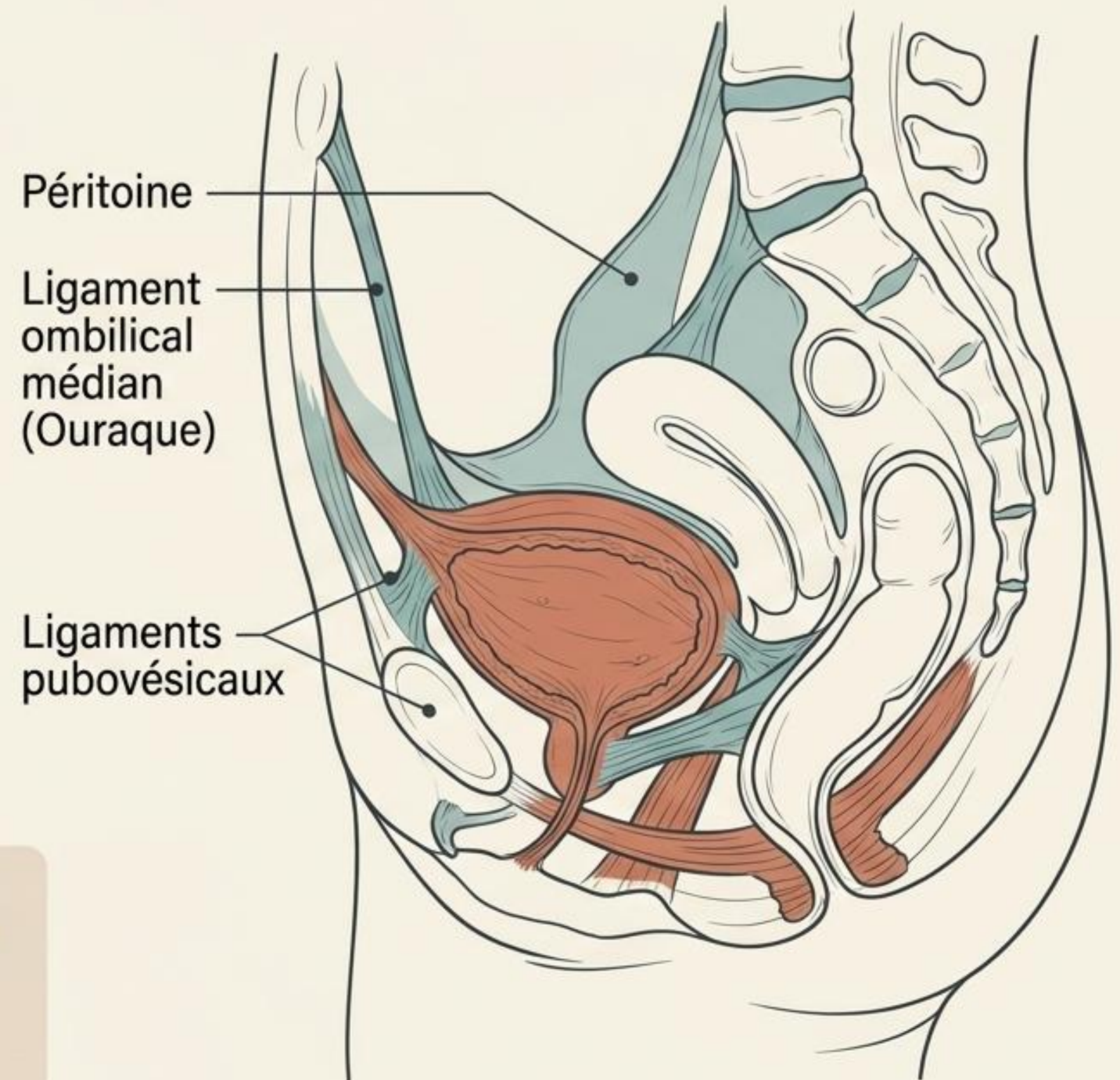
Encart ROP : La région cervico-trigonale est très hormono-dépendante. Les incontinenances peuvent apparaître par déséquilibres neuro-végétatifs et hormonaux liés au cycle menstruel ou au stress émotionnel.

Le Système de Suspension Mécanique

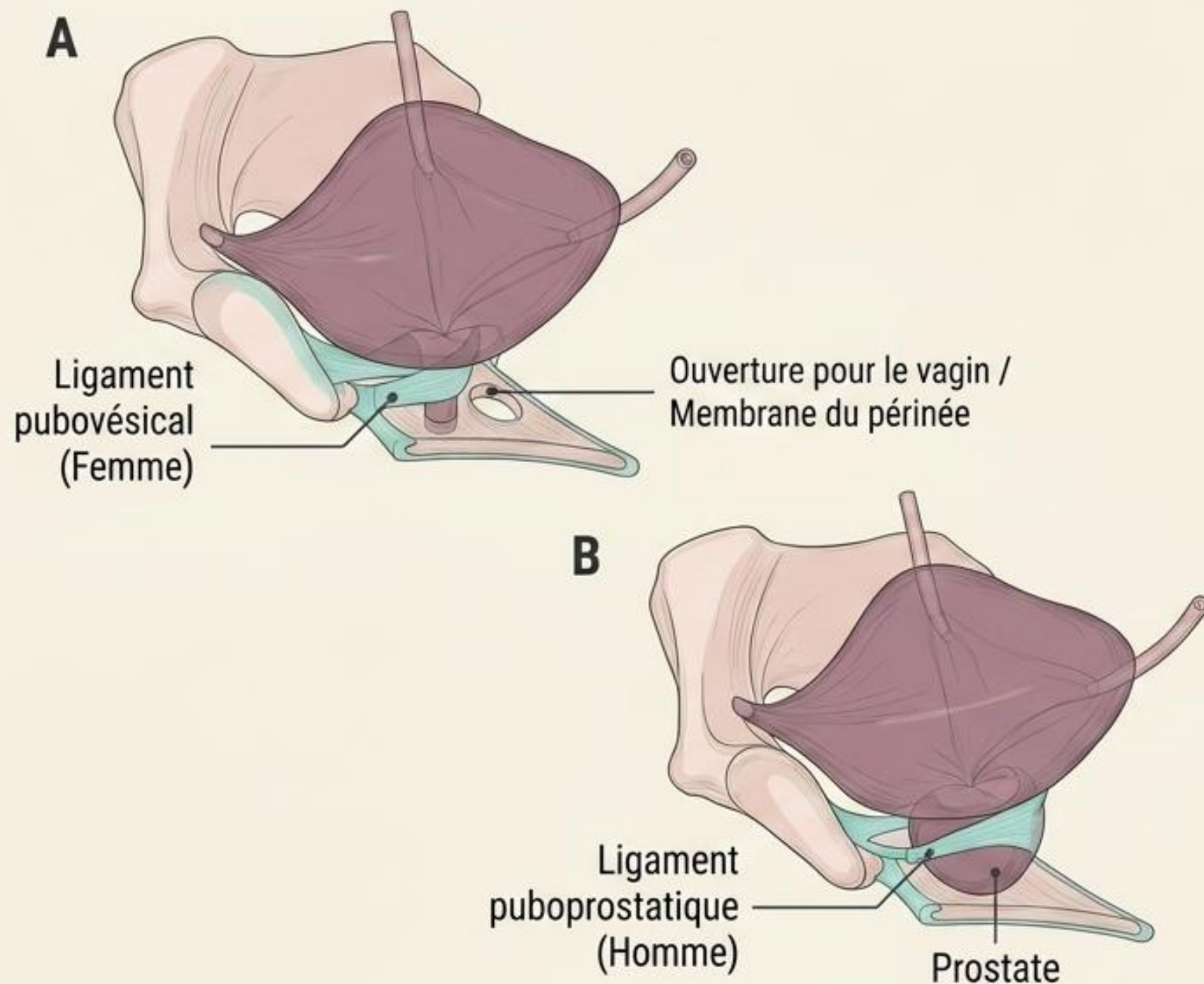
Analogie : Le ballon dans son filet

- **Péritoine** : Forme le cul-de-sac vésico-utérin/rectal. Sensible aux ptoses, chirurgies, et spasmes viscéraux.
- **Ligament ombilical médian (Ouraque)** : Relie l'ombilic à l'apex et au pubis (reliquat embryonnaire). Note clinique : Sa section lors d'une césarienne peut causer incontinence et éréthisme.
- **Ligaments pubovésicaux / puboprostatiques** : Fixent le col de la vessie au pubis. Fibres en stricte continuité avec le muscle détrusor.

Intérêt en ROP : Toute tension asymétrique des ligaments pubo-vésicaux crée un état d'hypercontractilité (éréthisme vésical) : envie impérieuse d'uriner par diminution de la capacité de remplissage et déstabilisation du col.



Amarrage et Soutènement Pelvien



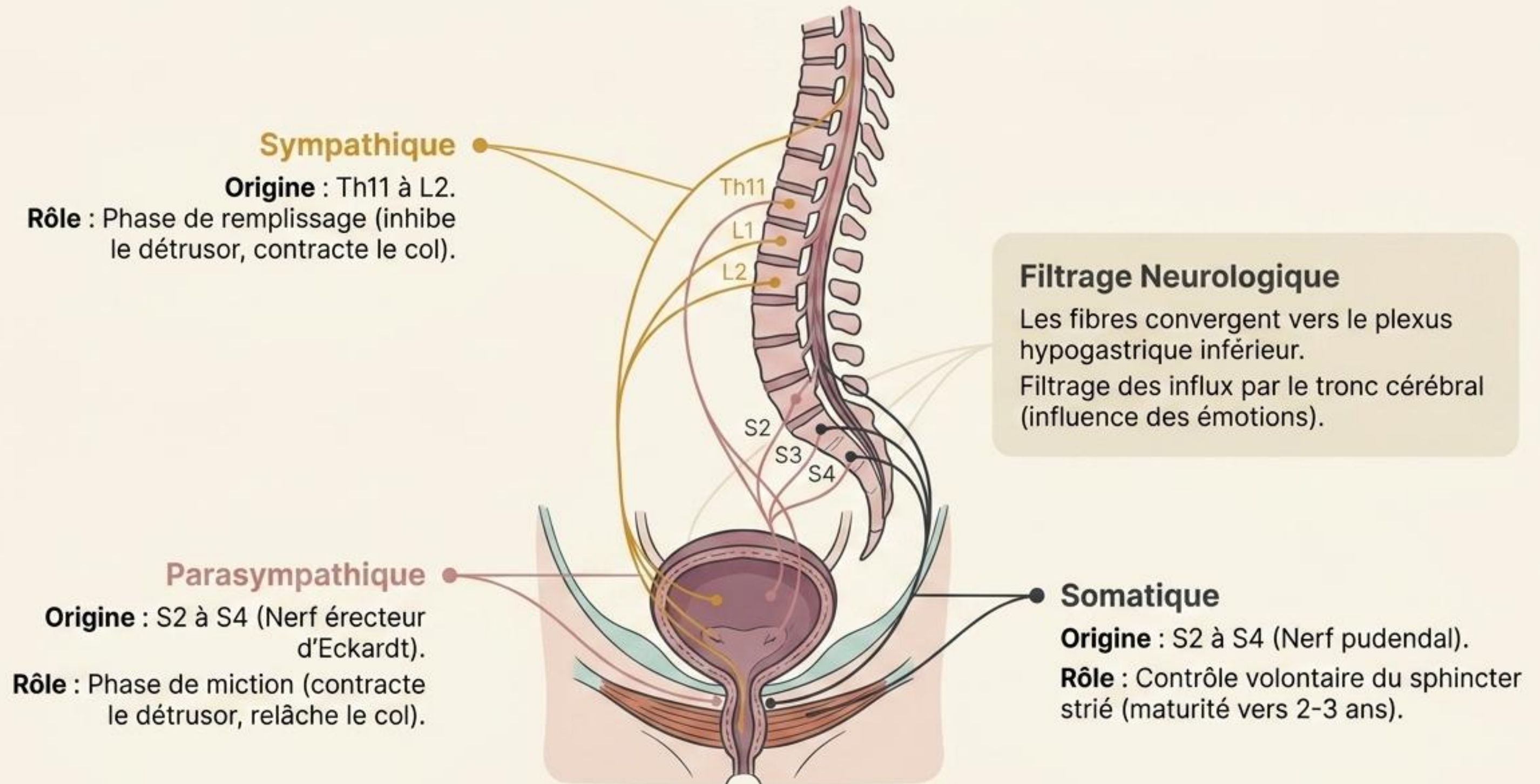
Le Système Suspenseur

- **Péritoine** : Épouse le sommet vésical (cul-de-sac). Les ptoses ou spasmes intestinaux retentissent directement sur la vessie.
- **Ligament ombilical médian (Ouraque)** : Relie l'apex à l'ombilic. Une cicatrice (ex: césarienne) peut causer des éréthismes.
- **Ligaments pubovésicaux** : Fixent le col au pubis. Leur tension déstabilise le col vésical (sensation de pesanteur).

Le Continuum Anatomique (ROP)

Le fonctionnement vésical dépend de ses **liens mécaniques avec le péritoine**, la **symphyse pubienne**, les **fosses obturatrices** et les **muscles de la hanche**.

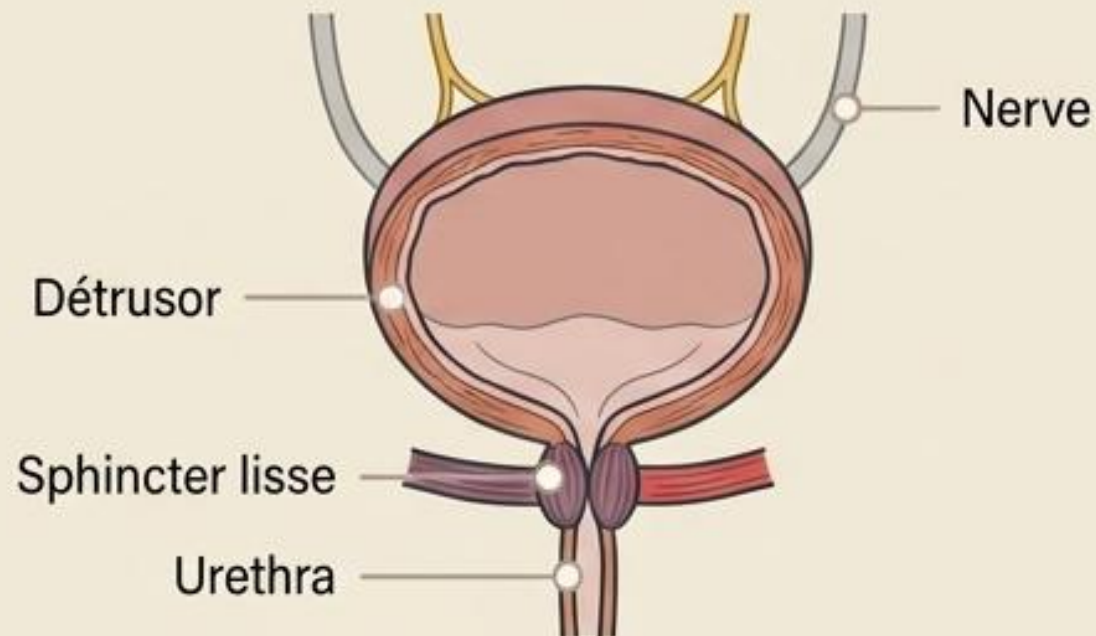
Câblage Neurologique : Contrôle Autonome et Somatique



Physiologie : Le Cycle de la Miction

Phase de Remplissage

Dominance Sympathique



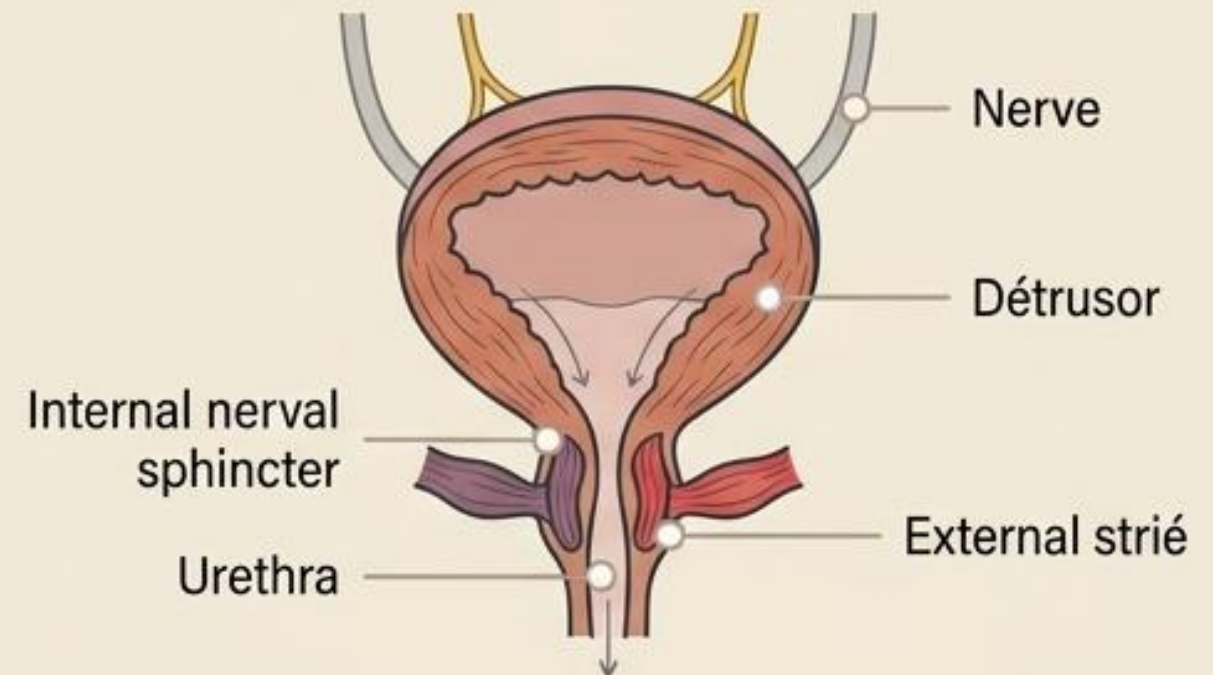
Pression intra-urétrale > Pression intra-vésicale.

Détrusor : Relâché.

Sphincter lisse : Contracté.

Phase de Miction

Dominance Parasympathique



Détrusor : Contracté (forme d'entonnoir).

Sphincters : Relâchés (lisse et strié).

Action finale : Intervention des abdominaux et muscles bulbo-spongieux pour l'expulsion.

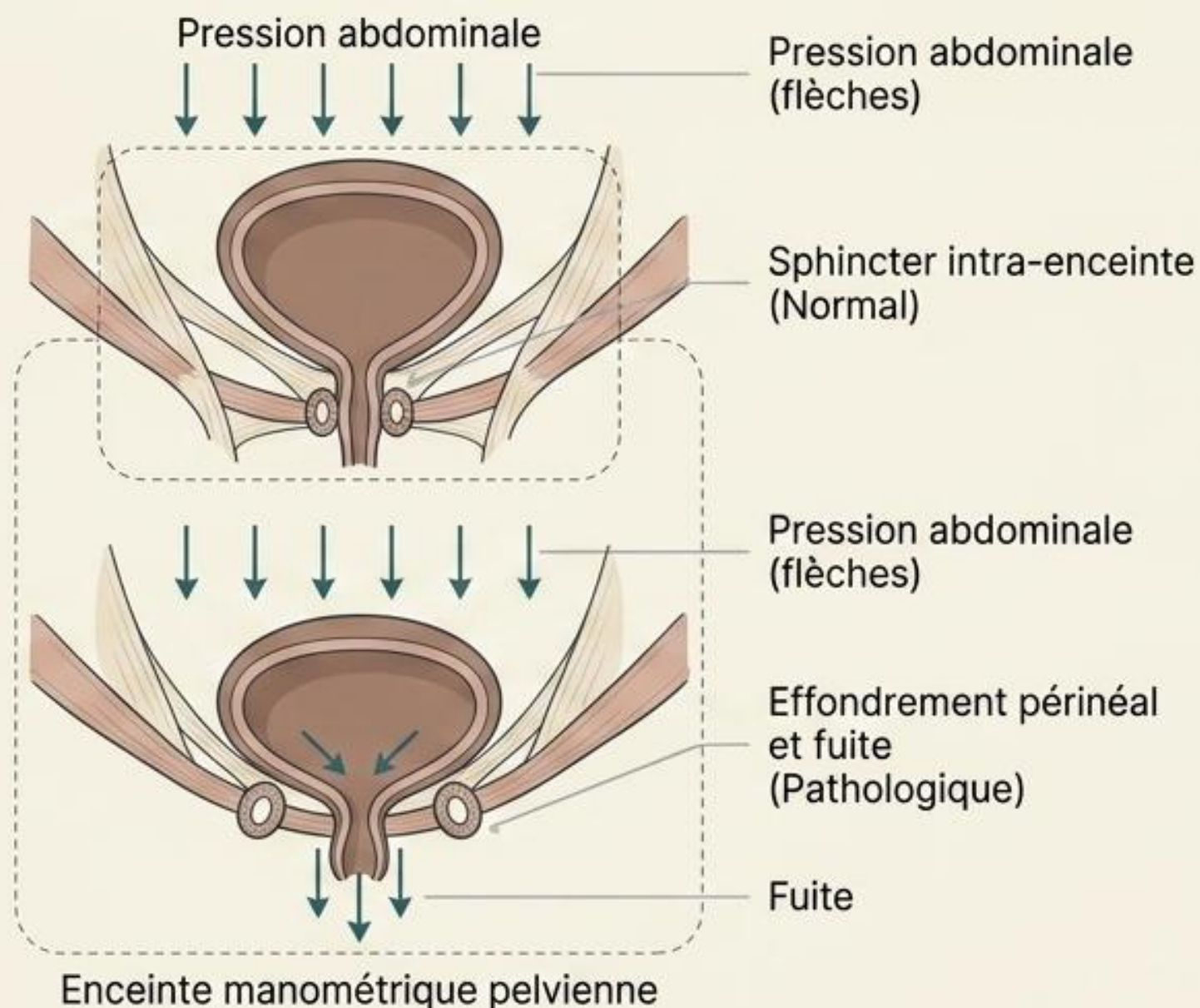
~300ml : Premier besoin ressenti.

~500ml : Deuxième besoin.

~700-800ml : Envie impérieuse.

Seuils de Volume

Biomécanique : L'Enceinte Manométrique Pelvienne



Le Mécanisme de Continence

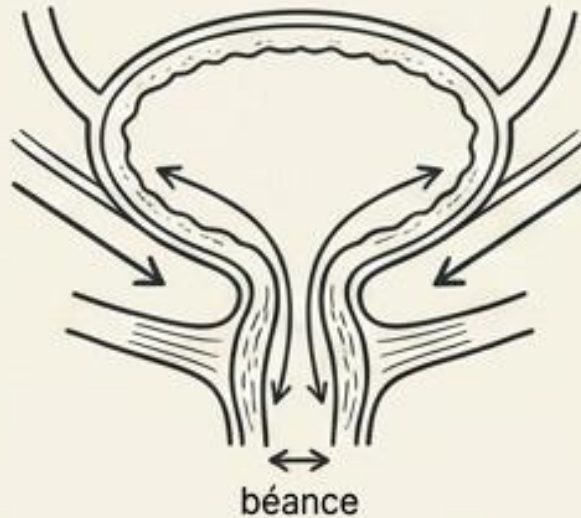
Pour que les sphincters résistent à la pression abdominale (toux, effort), l'urètre doit impérativement rester à l'intérieur de l'enceinte manométrique pelvienne.

La Pathologie (Effondrement)

Si le plancher pelvien s'affaisse, l'urètre sort de l'enceinte. Lors d'un effort, la pression abdominale s'exerce uniquement sur le dôme de la vessie, écrasant le détrusor sans renforcer le sphincter. Le résultat mécanique inévitable est l'Incontinence Urinaire d'Effort (IUE).

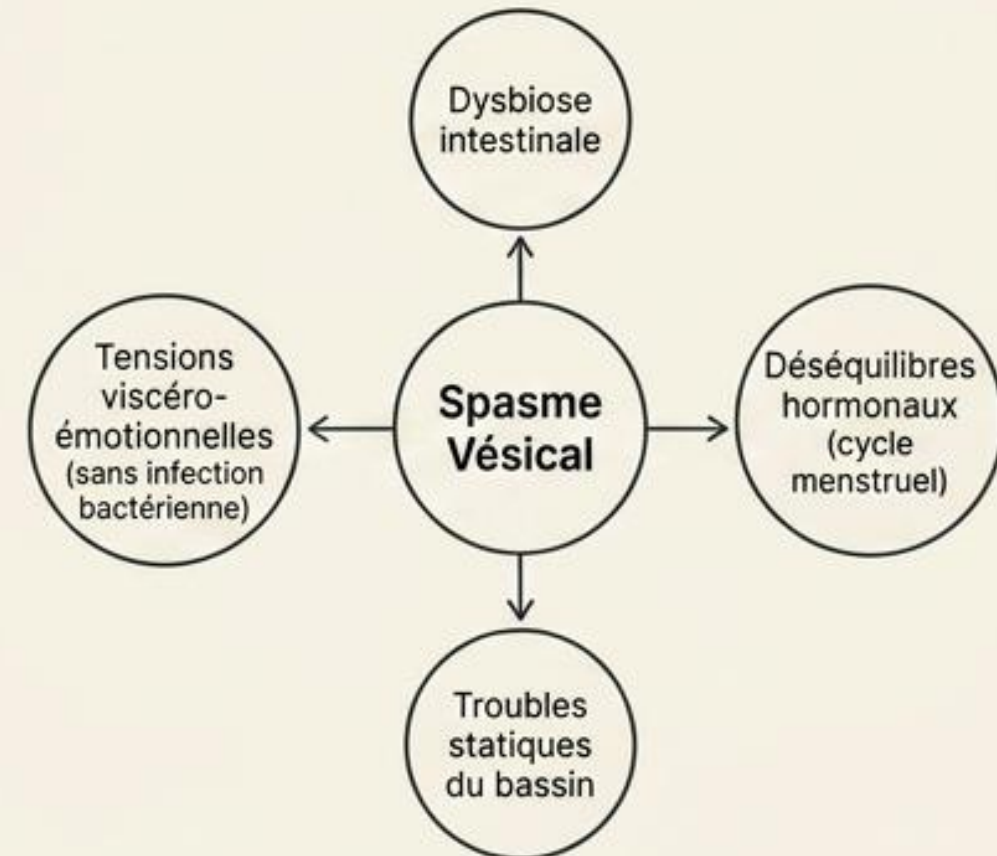
Mécanismes Pathologiques et Dysfonctions

1. L'Incontinence Urinaire d'Effort (IUE)



- **Tension antérieure** : Les ligaments pubovésicaux étirent la berge antérieure de l'urètre (souvent lié à une fixation de la symphyse pubienne).
- **Tension postérieure** : Les fascias tirés par une fixation du coccyx étirent la berge postérieure.
- **Résultat** : Béance mécanique du sphincter sous l'effort.

2. Cystites et Cystalgies Chroniques



Diagnostic Différentiel Clé

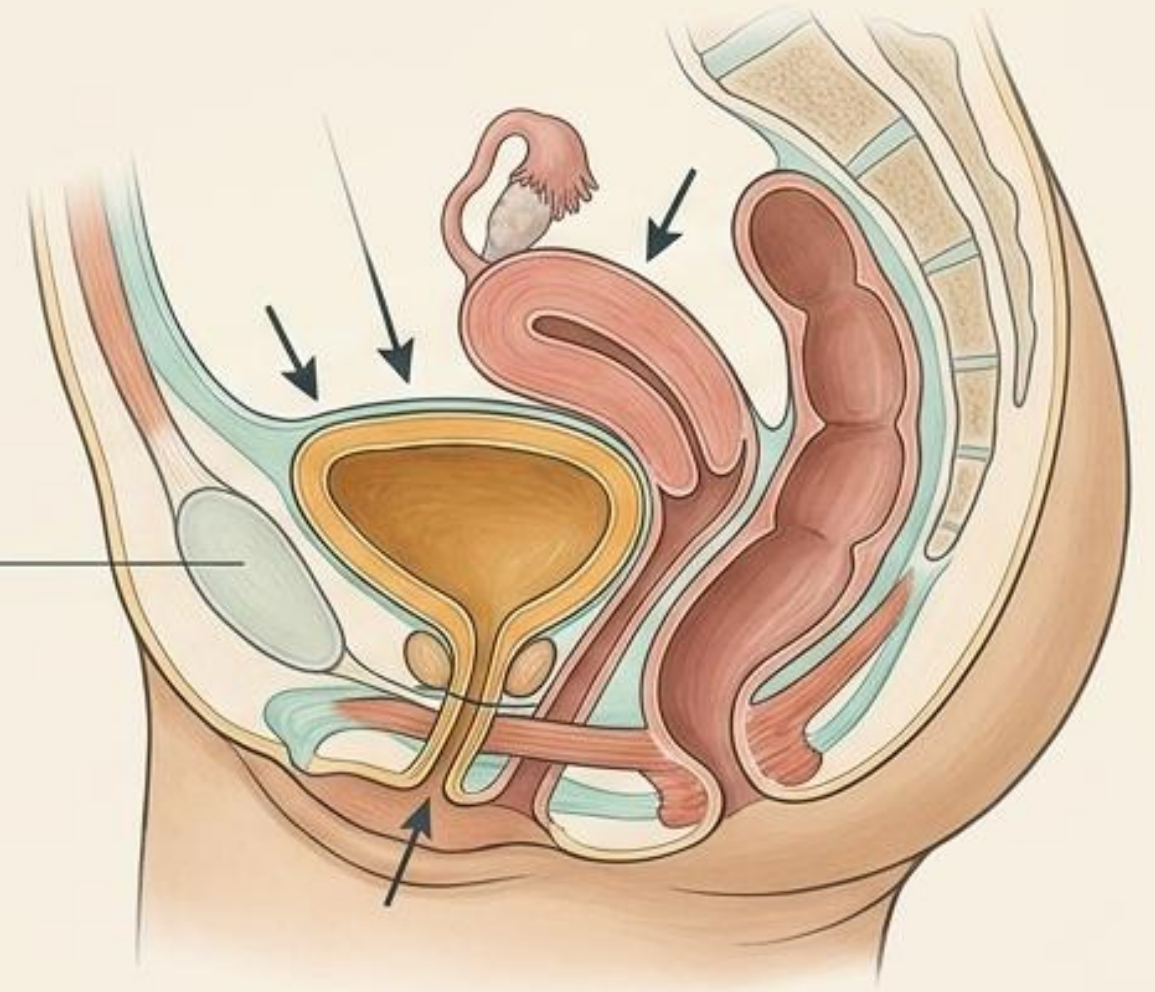
Fuite non précédée d'un besoin :
Indique une lésion structurelle, une IUE mécanique ou une atteinte neurologique.

Fuite précédée d'un besoin :
Indique une urgurie/éréthisme (spasmes, peur, contact de l'eau).

Biomécanique : L'Enceinte Manométrique Pelvienne

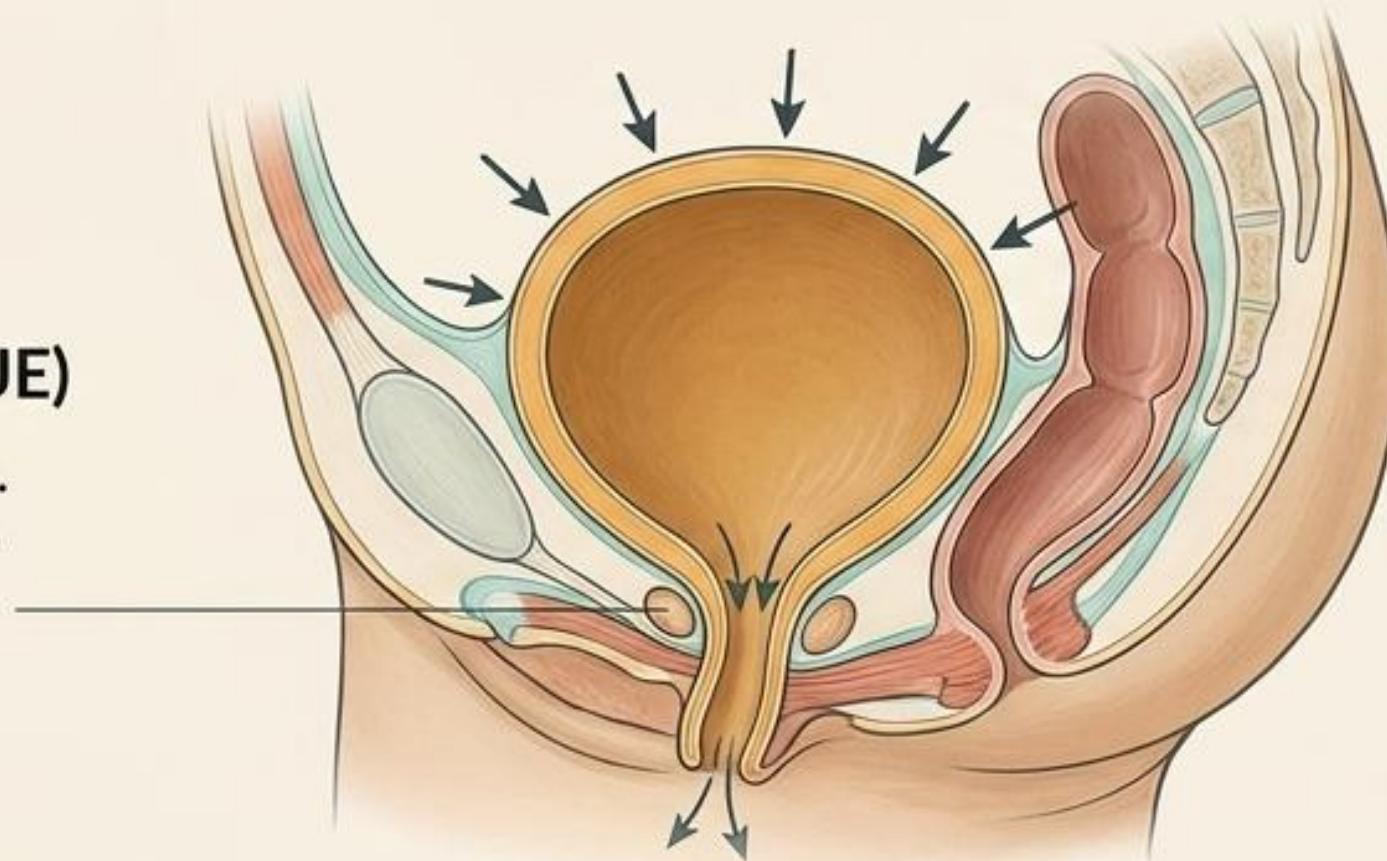
État Physiologique

L'urètre et le sphincter sont maintenus à l'intérieur de l'enceinte.
La pression abdominale (toux, effort) renforce la fermeture sphinctérienne.



État Pathologique (IUE)

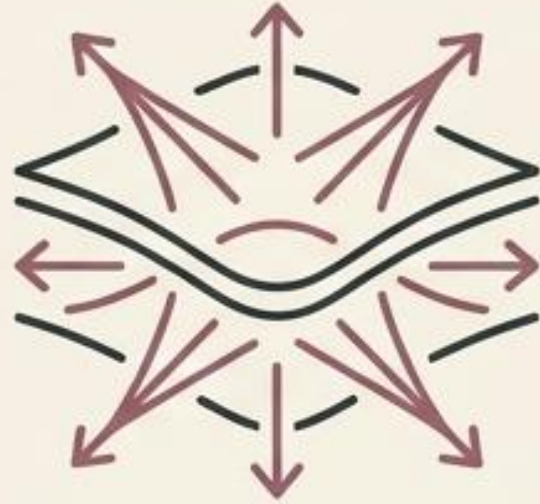
Effondrement du périnée.
L'urètre sort de l'enceinte manométrique.



Note Biomécanique

Lors d'un effort, la pression s'exerce uniquement sur la vessie et expulse l'urine au lieu de verrouiller le sphincter, provoquant l'Incontinence Urinaire d'Effort (IUE).

Pathologie : Incontinence Urinaire d'Effort (IUE)



Mécanismes Lésionnels Fasciaux

Les contractions abdominales l'emportent sur les forces occlusales en raison de dysfonctions fasciales :

- Béance Antérieure : Une fixation de la symphyse pubienne met en tension les ligaments pubo-vésicaux, étirant la berge antérieure de l'urètre.
- Béance Postérieure : Une fixation du coccyx tend les fascias postérieurs, étirant la berge postérieure de l'urètre.

Cible Thérapeutique ROP

L'objectif est de rééquilibrer la tension des fascias entourant l'urètre pour réintroduire le sphincter dans l'enceinte manométrique.

Axes de traitement :

- Plexus pudendal
- Attaches périnéales sur le coccyx
- Symphyse pubienne et branches ischio-pubiennes
- Noyau fibreux central du périnée

Diagnostics Différentiels : Cystites et Impériosités



Fuite précédée d'un besoin (Urgenturie / Éréthisme)

- Vessie morphologiquement normale mais souffrant d'une excitation anormale.
 - Facteurs déclenchants : Tension des ligaments pubo-vésicaux, émotivité/peur, contact de l'eau, comportement préventif (pollakiurie).
-



Cystites et Cystalgies

- Inflammation avec ou sans infection. Souvent récidivante.
 - Cibles ROP : Au-delà de l'infection, agir sur le terrain : dysbiose intestinale, déséquilibres hormonaux, et troubles statiques du bassin perturbant la dynamique vésicale.
-



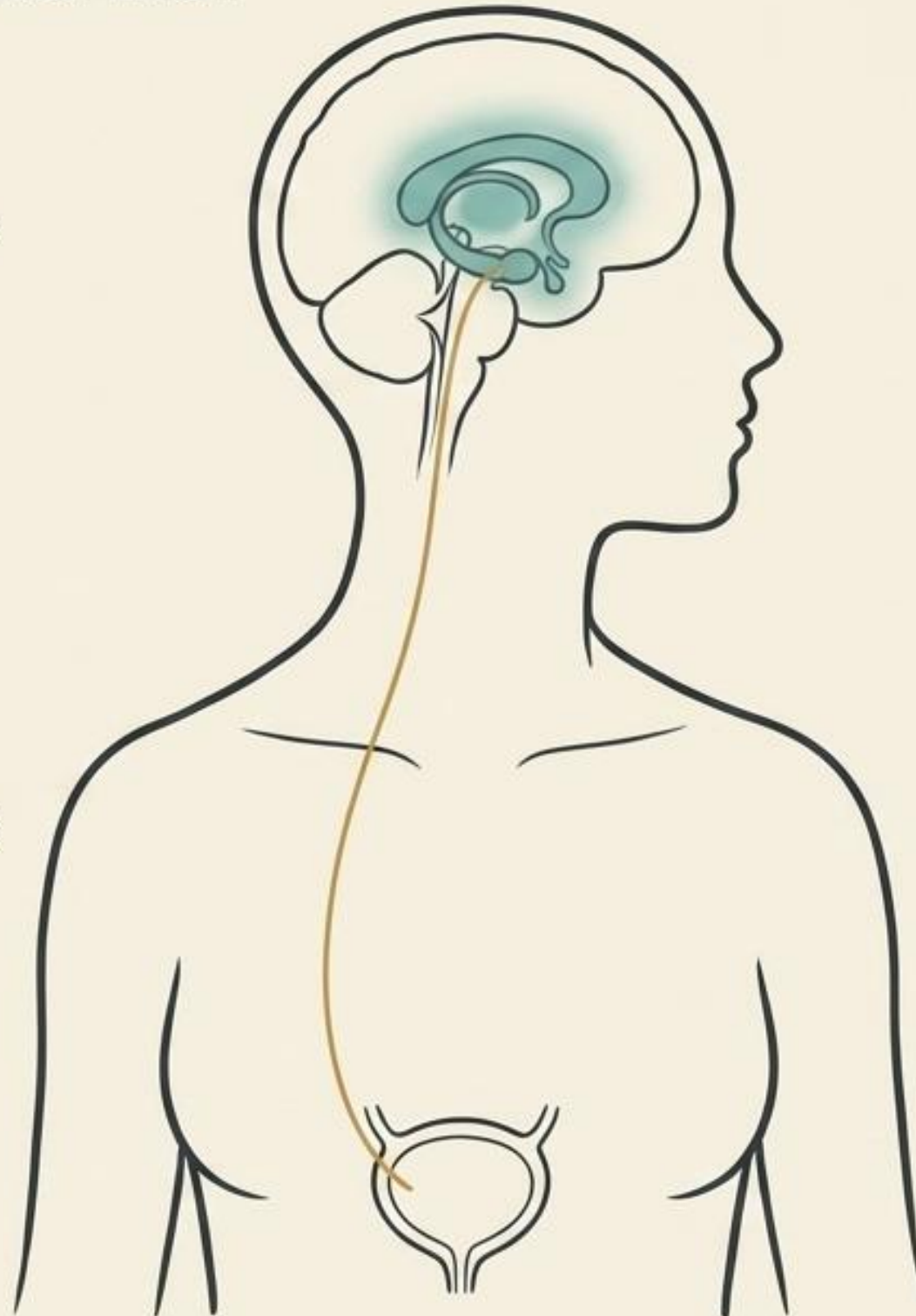
Diagnostics d'Exclusion (Drapeaux Rouges)

- Fuite non précédée d'un besoin en dehors de tout effort.
- Suspensions nécessitant une réorientation : Tumeur, lésions neurologiques périphériques (spina bifida) ou centrales (Sclérose en plaques, paraplégie), hématurie, rétention chronique.

Le Profil Viscéro-Émotionnel

Origine : La Pression Éducative

- Éducation stricte à la propreté durant l'enfance (dressage, chantage affectif).
- Le système limbique (siège des émotions et de la peur) prend le pas sur le contrôle du cortex.
- Résultat physique : Impossibilité neurologique de 'lâcher prise', générant des spasmes de la vessie et une pollakiurie émotionnelle.



Le Profil Clinique 'Vessie'

- Comportement : Personnalité réservée, effacée, soumise. Connaît souvent plus ses devoirs que ses droits.
- Socio-spatial : Marche à petits pas, occupe mal son territoire spatial en société.
- Émotion dominante : La culpabilité ('Je sais que c'est de ma faute'). Un excès de pudeur bloque l'acceptation corporelle.

Conseils Pratiques : Gymnastique Périnéale Hypopressive



1. Décubitus Dorsal Déclive

Bassin rétroversé sur coussin, jambes surélevées au mur.
Expiration nasale + traction sus-pubienne vers l'ombilic.



2. Renforcement des Rotateurs

Jambes allongées en rotation externe. Appui sur le bord externe des pieds, contraction des fessiers, poussée du pubis vers le haut.



3. Sollicitation des Adducteurs

Genoux pliés, serrer un objet entre les genoux pour renforcer les fibres sphinctériennes.



4. Position Quadrupédique

En appui sur les coudes. Expiration nasale par saccades en rentrant le ventre (rôle expirateur du transverse).

Règle Fondamentale : Ne jamais renforcer les abdominaux en post-partum avant d'avoir rééquilibré les fascias pour réintroduire le sphincter dans l'enceinte manométrique.

Hydratation : En cas de cystalgies, boire de l'eau en petite quantité, mais de manière très régulière.

Conseils Pratiques et Gymnastique Périnéale

Respiration Hypopressive (IUE)

Décubitus dorsal, bassin rétroversé et surélevé.

Expiration nasale couplée à une traction sus-pubienne (pulpe des doigts vers l'ombilic) pour solliciter le transverse sans pousser sur le plancher.



Renfort des Rotateurs Externes

Décubitus dorsal, jambes allongées en rotation externe.

Appui sur le bord externe des pieds, contraction des fessiers et élévation du pubis pour refermer la symphyse.



Sollicitation Sphinctérienne

Décubitus dorsal, genoux pliés. Serrer un livre entre les genoux pour activer les adducteurs des hanches et renforcer les fibres sphinctériennes par irradiation. Stop-pipi ponctuel conseillé.



Gestion Posturale (Toux/Effort)

Se pencher en avant, mains en appui sur les genoux avant un éternuement ou une toux. Déplace la pression intra-abdominale vers l'avant, protégeant l'enceinte pelvienne.

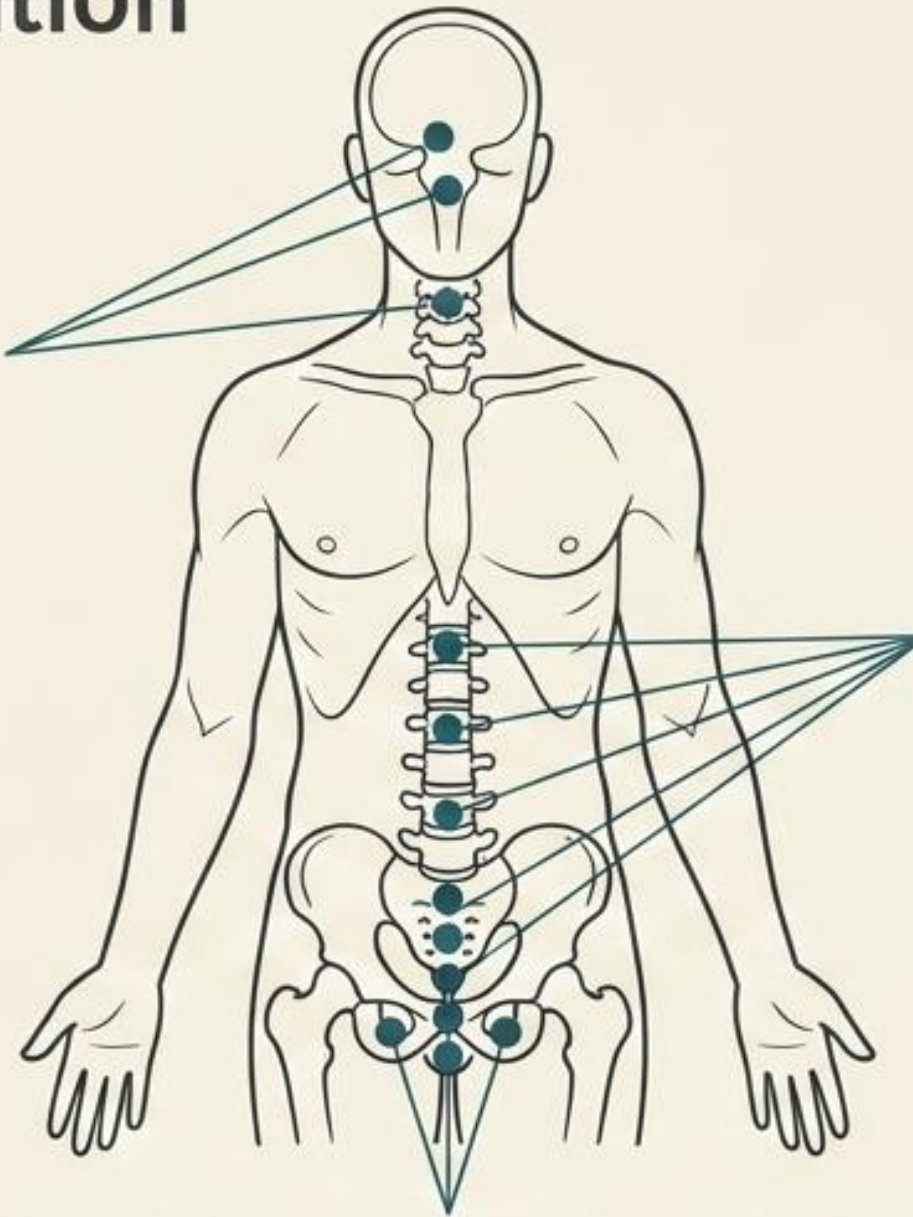


Précaution Post-Partum : Éviter tout renforcement abdominal précoce qui expulserait l'urètre de l'enceinte manométrique. Rééquilibrer les fascias d'abord.

L'Approche Thérapeutique ROP : Cartographie d'Intervention

Axe Crânio-Sacré (Régulation Limbique) :

- Symphyse sphéno-basilaire.
- Tronc cérébral et Hypothalamus.
- **Indication** : Énurésie, dominance émotionnelle, peurs.



Axe Neuro-Végétatif (Innervation) :

- Sympathique : Vertèbres Th11 à L2.
- Parasympathique : Sacrum S2-S4 et Coccyx.
- **Indication** : Restauration du balancier neurologique de remplissage/miction.

Axe Biomécanique (Structure Pelvienne) :

- Symphyse pubienne et fosses obturatrices.
- Noyau fibreux central du périnée et plexus pudendal.
- **Indication** : Rééquilibrer la tension des fascias urétraux (IUE) et relâcher les ligaments pubo-vésicaux.

L'Approche ROP : Cartographie des Zones Podales

Syndrome Général d'Adaptation

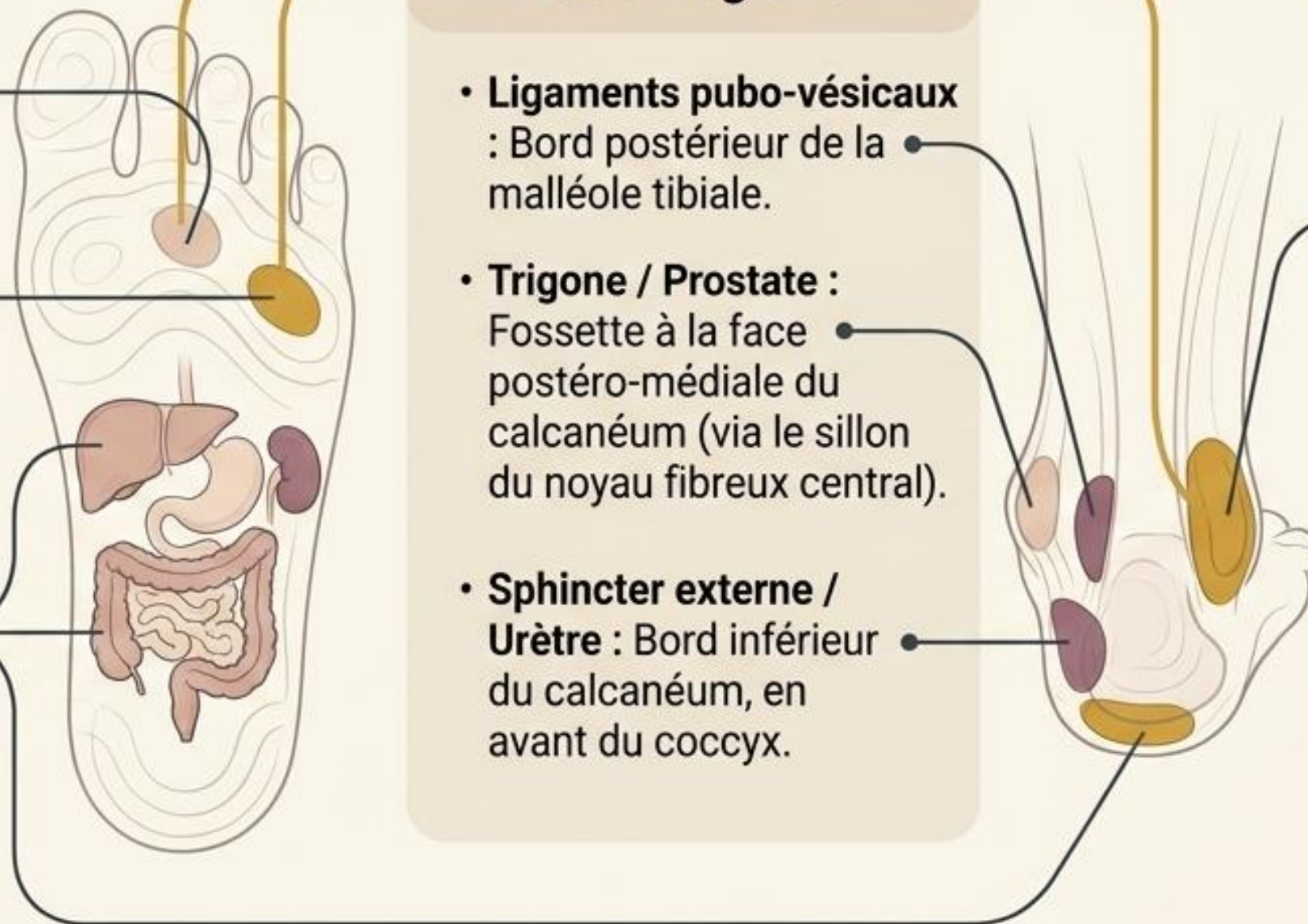
- **Parasympathique pelvien :** Moelle sacrée S2-S4 (Étage vertébral L1-L2).
- **Sympathique :** Articulations costo-transversaires Th10-L2, chaîne ganglionnaire lombo-sacrée.
- **Organes cibles :** Foie, intestins, reins (pour cystites chroniques).

Syndrome Loco-Régional

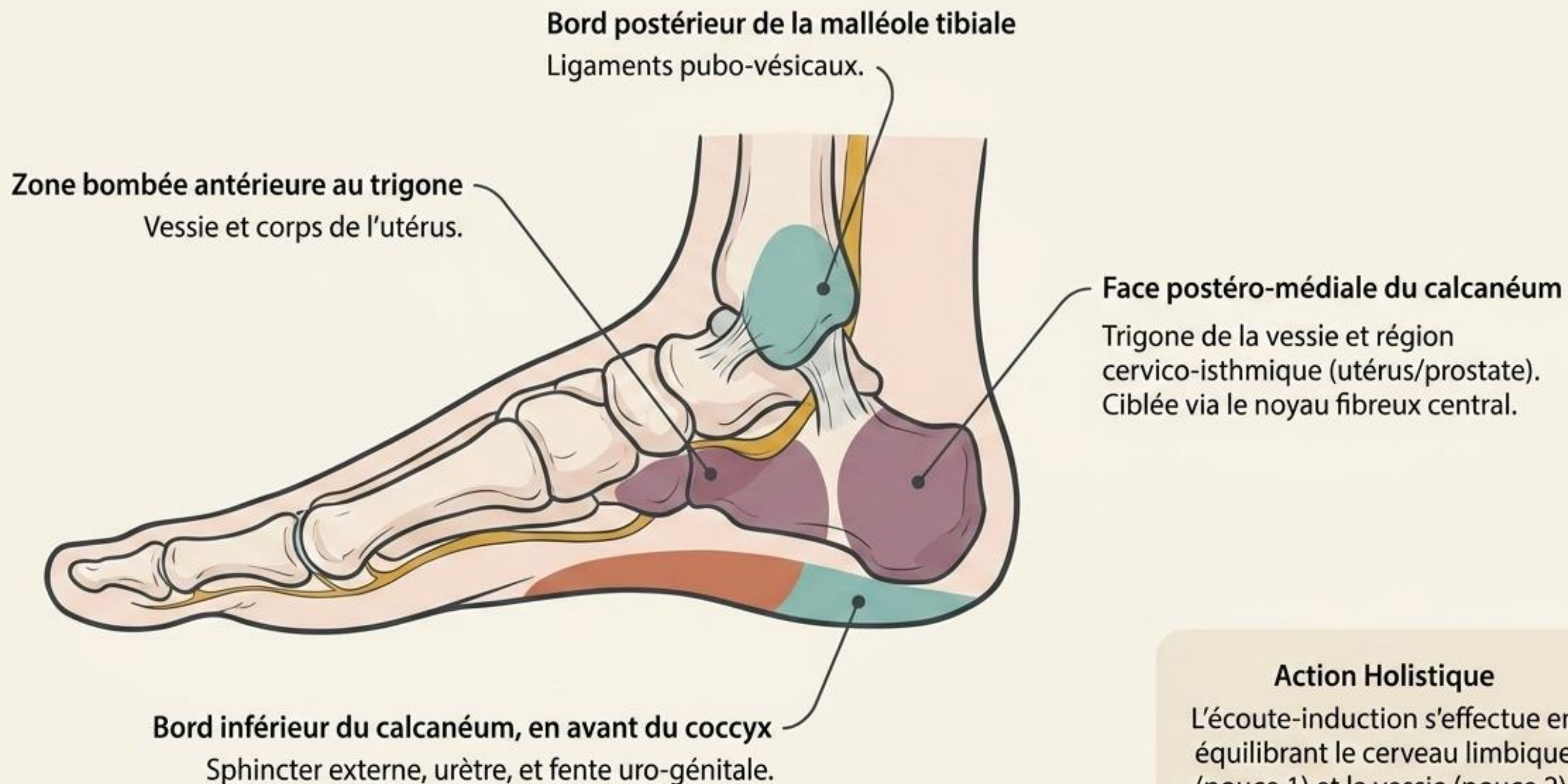
- **Ligaments pubo-vésicaux :** Bord postérieur de la malléole tibiale.
- **Trigone / Prostate :** Fossette à la face postéro-médiale du calcaneum (via le sillon du noyau fibreux central).
- **Sphincter externe / Urètre :** Bord inférieur du calcaneum, en avant du coccyx.

Système Limbique

- **Balance Émotionnelle :** Écoute et induction simultanée — un pouce sur la zone réflexe de la vessie, l'autre sur le cerveau limbique.



Application ROP : Zones Réflexes Podales



Action Holistique

L'écoute-induction s'effectue en équilibrant le cerveau limbique (pouce 1) et la vessie (pouce 2).